Infections Urinaires Masculines Aiguës Communautaires de l'Adulte (IUMACA)

Mise à jour des recommandations

Jeu de diapositives réalisé par le comité des référentiels de la SPILF

le …20/06/2026

A partir de …publication

Sociétés associées

- Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
- Société Française de Gériatrie et Gérontologie
- Association Française d'Urologie
- Société Française de Médecine d'Urgence
- Société Française de Microbiologie
- Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique
- Société Nationale de Médecine Interne
- Collège National des Généralistes Enseignants

Introduction/contexte

- Cadre de cette recommandation : infections urinaires aiguës, communautaires, de l'homme, adulte

- Ne sont pas traitées, les infections urinaires :
  - Du patient immunodéprimé
  - Du patient porteur de sonde urinaire (vésicale, urétérale ou néphrostomie)
  - Du patient avec vessie neurologique
  - Liées aux soins
  - Récidivantes

Définitions (1)

Colonisation urinaire bactérienne

- Détection à l'ECBU d'une ou plusieurs bactéries (quelles que soient leur concentration et la leucocyturie) en l'absence de symptômes

- Recherche ou traitement d'une colonisation urinaire : non indiqués, sauf avant certains gestes urologiques

- Hématurie macroscopique ou rétention aiguë d'urine, isolées, ne sont pas des signes cliniques d'infection urinaire

Dans ces situations il n'est pas recommandé de réaliser un ECBU ni de traiter une éventuelle colonisation urinaire

Définitions (2)

Bactériurie de signification clinique indéterminée

- Présence d'une bactériurie associée à des signes généraux non spécifiques et à l'absence de signes clinique de cystite
- Dans cette situation et en l'absence de sepsis*, une surveillance clinique sans antibiothérapie est recommandée

⋆ Sepsis : infection avec dysfonction d'organe

Bandelette urinaire, ECBU

Bandelette urinaire

Non recommandée dans la stratégie diagnostique

ECBU

- Recommandé pour le diagnostic de toute infection urinaire avant de débuter une antibiothérapie
- Seuils de significativité : leucocyturie $30x10^3$/mL, et bactériurie monomicrobienne $\geq 10^3$ UFC/mL pour les principaux uropathogènes
- La présence de signes cliniques d'infection urinaire prime sur les seuils de leucocyturie et de bactériurie

ECBU

Non recommandé dans les situations suivantes :

- Rétention aiguë d'urine isolée
- Signes généraux non spécifiques du sujet âgé (confusion, dépendance aiguë, altération brutale de l'état général, décompensation d'organe, chute) lorsqu'il n' y a pas de signes d'infection urinaire associés
- Après un traitement antibiotique curatif conduisant à la guérison clinique

Cystite aiguë bactérienne, diagnostic

- Diagnostic clinique : présence de signes cliniques locaux, d'apparition aigüe, et absence de fièvre
- Signes locaux : brûlures urétrales per-mictionnelles, pollakiurie, urgenturie, dysurie, nycturie, douleur de l'hypogastre. L'association d'une hématurie macroscopique est possible
- ECBU : seul examen complémentaire recommandé pour confirmer le diagnostic
- Prélèvement sanguin : non recommandé (pas de dosage du PSA ni des marqueurs de l'inflammation)

Cystite aiguë bactérienne antibiothérapie initiale

- Si bonne tolérance ou diagnostic douteux : attendre les résultats de l'ECBU pour débuter un traitement antibiotique adapté à la documentation microbiologique et l'antibiogramme

- Dans le cas contraire, **traitement oral probabiliste, par ordre alphabétique :**
  - Fosfomycine-trométamol (3 g à J1-J3-J5)
  - Nitrofurantoïne 100 mgx3/j
  - Pivmécillinam 400 mgx2/j

Cystite aiguë bactérienne antibiothérapie après documentation

- Poursuite du traitement probabiliste si uropathogène sensible
- Sinon, adaptation selon antibiogramme, par ordre alphabétique :
  - Amoxicilline 1 gx3/j
  - Fosfomycine-trométamol 3 g/prise
  - Nitrofurantoïne 100 mgx3/j
  - Pivmécillinam 400 mgx2/j
  - Triméthoprime 300 mgx1/j

Cystite, durée de l’antibiothérapie

- 7 jours
- Sauf fosfomycine-trometamol : 3 doses (J1-J3-J5)

Prostatite aiguë, diagnostic

- Signes cliniques de cystite + fièvre ou manifestations systémiques d'infection + ECBU positif
- Toucher rectal : uniquement si doute sur diagnostic entre cystite et prostatite
- Dosage du PSA : non recommandé
- Si prise en charge ambulatoire :
  - Dosage de la créatinine sérique non recommandé sauf facteurs de risque d'insuffisance rénale aiguë (insuffisance rénale chronique, antécédents urologiques, déshydratation, traitements à risque : diurétiques, IEC, AINS, aminosides…)
  - Dosage des marqueurs inflammatoires et hémocultures non recommandés

Prostatite aiguë, imagerie

Recommandée uniquement dans les situations suivantes :

- En urgence :
  - Si sepsis ou choc septique : scanner abdomino-pelvien injecté
  - Si doute sur une rétention aiguë d'urine : bladder scanner ou échographie sus-pubienne, pour un drainage en urgence si rétention d'urine

- Après 72h d'une antibiothérapie adaptée :

  En cas de mauvaise évolution clinique (persistance de la fièvre ou aggravation des signes urinaires) → IRM ou TDM injectée ou échographie prostatique par voie endo-rectale à la recherche d'un abcès prostatique

Prostatite aiguë, antibiothérapie initiale (1)

- **Absence de signes de gravité**
  - Traitement initié en milieu hospitalier : céfotaxime IV 3 g/jour OU ceftriaxone IV 1 g/jour
  - Traitement initié en ambulatoire :
    - Ceftriaxone IV ou IM ou SC 1 g/jour
    - Ou ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour

      (en l'absence de prise de fluoroquinolones dans les 6 mois, nausées, vomissements, malabsorption, observance incertaine…)
- **Sepsis**

  Céfotaxime IV 6 g/jour OU ceftriaxone IV 2 g/jour

  ET amikacine IV 30 mg/kg, dose unique

Prostatite aiguë, antibiothérapie initiale (2)

- **Choc septique***
  - Si pas de facteurs de risque d'infection à Enterobacterales résistantes aux C3G ** :

    Céfotaxime IV 6 g/jour OU ceftriaxone IV 2 g/jour

    ET amikacine IV 30 mg/kg, dose unique
  - Si au moins 1 facteur de risque d'infection à Enterobacterales résistantes aux C3G** : Imipénème IV 3 g/jour OU méropénème IV 6 g/jour

    ET amikacine IV 30 mg/kg, dose unique

*Sepsis + défaillance hémodynamique nécessitant un vasopresseur **et** lactatémie > 2 mmol/l

** Patient vivant dans un EHPAD - Infection et/ou colonisation à Enterobacterales résistant aux C3G dans les 3 mois - Voyage à l'étranger dans les 3 mois - Prise de fluoroquinolones, amoxicilline-acide clavulanique ou C3G dans les 3 mois

Prostatite aiguë, antibiothérapie, relais en fonction de l'antibiogramme (1)

- Relais oral possible**,** par ordre préférentiel
  - Sulfaméthoxazole-triméthoprime PO 800/160 mg 1 cpx2/jour
  - Ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour OU ofloxacine PO 200 mgx2/jour
  - Si résistance ou contre-indication à l'association sulfaméthoxazole-triméthoprime et aux fluoroquinolones, après retour à l'apyrexie et par ordre préférentiel :

    Fosfomycine-trométamol 3 g tous les jours OU amoxicilline PO 1 gx3/jour OU amoxicilline-acide clavulanique PO 1 gx3/jour

- **Si pas de relais oral possible :** céfotaxime IV 3 g/jour OU ceftriaxone IV, IM ou SC 1 g/jour

Prostatite aiguë, antibiothérapie, relais en fonction de l'antibiogramme (2)

Enterobacterales résistantes aux C3G

- Par hyperproduction de céphalosporinase : céfépime IV 4 g/jour OU témocilline IV 6 g/jour
- Par production de BLSE :
  - 1er choix, par ordre alphabétique : céfoxitine IV 6 g/jour (seulement si *E. coli* ou *Proteus*) OU pipéracilline-tazobactam IV 12 g/jour OU témocilline IV 6 g/jour
  - A défaut, par ordre alphabétique : ertapénème IV 1 g/jour OU imipénème IV 3 g/jour OU méropénème IV 3 g/jour
- Relais oral, par ordre de préférence : sulfaméthoxazole-triméthoprime PO 800/160 mg 1 cpx2/jour, ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour OU ofloxacine PO 200 mgx2/jour, fosfomycine-trométamol 3 g tous les jours

Prostatite aiguë, durée de l’antibiothérapie

14 jours

Pyélonéphrite aiguë, diagnostic

- Douleurs lombaires spontanées ou à l'ébranlement + fièvre ou manifestations systémiques d'infection +/- signes de cystite + ECBU positif
- Signes de cystite inconstants
- Si prise en charge ambulatoire :
  - Dosage de la créatinine sérique non recommandé sauf facteurs de risque d'insuffisance rénale aiguë (insuffisance rénale chronique, antécédents urologiques, déshydratation, traitements à risque : diurétiques, IEC, AINS, aminosides…)
  - Dosage des marqueurs inflammatoires et hémocultures non recommandés

Pyélonéphrite aiguë, imagerie

- Scanner abdomino-pelvien injecté systématique dans les 48-72h pour rechercher une uropathie
- Dans l'attente du scanner, si suspicion de rétention d'urines : bladder scanner ou échographie sus-pubienne en urgence pour un drainage des urines
- Scanner en urgence si :
  - Sepsis ou choc septique
  - Douleurs non contrôlées
  - Suspicion d'obstacle des voies urinaires (calcul, tumeur…)
  - Présence de matériel endo-urétéral
  - Insuffisance rénale aiguë

Pyélonéphrite aiguë, antibiothérapie initiale (1)

- **Absence de signe de gravité**
  - Traitement initié en milieu hospitalier : céfotaxime IV 3 g/jour OU ceftriaxone IV 1 g/jour
  - Traitement initié en ambulatoire :
    - Ceftriaxone IV ou IM ou SC 1 g/jour
    - Ou ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour (en l'absence de prise de fluoroquinolones dans les 6 mois, nausées, vomissements, malabsorption, observance incertaine…)
- **Sepsis**

  Céfotaxime IV 6 g/jour OU ceftriaxone IV 2 g/jour

  ET amikacine 30 mg/kg, dose unique

Pyélonéphrite aigüe, antibiothérapie initiale (2)

- **Choc septique***
  - Si pas de facteurs de risque d'infection à Enterobacterales résistantes aux C3G ** :

    Céfotaxime IV 6 g/jour OU ceftriaxone IV 2 g/jour

    ET amikacine IV 30 mg/kg, dose unique
  - Si au moins 1 facteur de risque d'infection à Enterobacterales résistantes aux C3G** : Imipénème IV 3 g/jour OU méropénème IV 6 g/jour

    ET amikacine IV 30 mg/kg, dose unique

*Sepsis + défaillance hémodynamique nécessitant un vasopresseur **et** lactatémie > 2 mmol/l

** Patient vivant dans un EHPAD - Infection et/ou colonisation à Enterobacterales résistant aux C3G dans les 3 mois - Voyage à l'étranger dans les 3 mois - Prise de fluoroquinolones, amoxicilline-acide clavulanique ou C3G dans les 3 mois

Pyélonéphrite aiguë, antibiothérapie, relais, en fonction de l'antibiogramme (1)

- **Relais oral possible,** par ordre préférentiel
  - Amoxicilline 1 gx3/jour
  - Sulfaméthoxazole-triméthoprime 800/160 mg 1 cpx2/jour
  - Amoxicilline-acide clavulanique 1 gx3/jour
  - Ciprofloxacine 500 mgx2/jour OU lévofloxacine 500 mg/jour OU ofloxacine 200 mgx2/jour
  - Céfixime 200 mgx2/jour

- **Si pas de relais oral possible :** céfotaxime IV 3 g/jour OU ceftriaxone IV, IM ou SC 1 g/jour

Pyélonéphrite aiguë, antibiothérapie, relais en fonction de l'antibiogramme (2)

Enterobacterales résistantes aux C3G

- Par hyperproduction de céphalosporinase : céfépime IV 4 g/jour OU témocilline IV 6 g/jour
- Par production de BLSE :
  - 1er choix, par ordre alphabétique : céfoxitine IV 6 g/jour (seulement si *E. coli* ou *Proteus*) OU pipéracilline-tazobactam IV 12 g/jour OU témocilline IV 6 g/jour
  - A défaut, par ordre alphabétique : ertapénème IV 1 g/jour OU imipénème IV 3 g/jour OU méropénème IV 3 g/jour
- Relais oral, par ordre de préférence : sulfaméthoxazole-triméthoprime PO 800/160 mg 1 cpx2/jour, ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour OU ofloxacine PO 200 mgx2/jour

Pyélonéphrite aiguë, durée de l’antibiothérapie

- 7 jours : si traitement par béta-lactamine parentérale et/ou fluoroquinolone et/ou sulfaméthoxazole-triméthoprime
- 10 jours : si autre(s) antibiotique(s) utilisé(s)

Prostatite aiguë, pyélonéphrite aiguë critères d'orientation vers l'hôpital (1)

- Sepsis ou choc septique → soins intensifs
- Risque de sepsis
  - Utiliser le score clinique composé de 6 variables (1 point par variable) :
    - Age > 65 ans
    - Température > 38°C
    - Pression artérielle systolique ≤ 110 mm Hg
    - Fréquence cardiaque > 110/min
    - Saturation périphérique en O_2 ≤ 95%
    - Troubles récents des fonctions supérieures

→ Si score clinique ≥ 3 : 40 % de risque de progression vers un sepsis

Prostatite aiguë, pyélonéphrite aiguë critères d'orientation vers l'hôpital (2)

- Prise orale impossible avec risque de non-observance et de déshydratation (troubles de la déglutition, nausées, vomissements, confusion, agitation, contexte social, isolement)
- Déclin fonctionnel ne permettant pas le maintien à domicile
- Décompensation de comorbidité(s) nécessitant une hospitalisation
- Douleur non contrôlée

Prostatite aigüe et pyélonéphrite aigüe, allergie contre-indiquant l'utilisation de toute béta-lactamine

- Traitement probabiliste
  - Absence de sepsis ou choc septique :

    Ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour, en l'absence de prise de fluoroquinolone dans les 6 mois

    - Si contre-indication aux fluoroquinolones :

      Amikacine IV 30 mg/kg dose unique et avis spécialisé

  - Sepsis ou choc septique

    Ciprofloxacine IV 400 mgx3/jour OU lévofloxacine IV 500 mgx2/jour ET Amikacine IV 30 mg/kg dose unique et avis spécialisé

Prostatite aiguë et pyélonéphrite aiguë, allergie contre-indiquant l'utilisation de toute béta-lactamine

- Relais oral par ordre de préférence :
  - Sulfaméthoxazole-triméthoprime PO 800/160 mg 1 cpx2/jour
  - Ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour OU ofloxacine PO 200 mgx2/jour
  - Fosfomycine-trométamol 3 g tous les jours (uniquement si prostatite)

- Si pas de relais oral possible : avis spécialisé

Epididymite aiguë et orchite aiguë, diagnostic

- Diagnostic clinique : tuméfaction, douleur spontanée ou à la palpation de l'épididyme ou du testicule, d'apparition aiguë
- Autres signes cliniques pouvant être associés : fièvre, hydrocèle, érythème et œdème du scrotum, signes de cystite, écoulement urétral
- Diagnostic différentiel : torsion du cordon spermatique (urgence)
- ECBU systématique
- Homme sexuellement actif, quel que soit son âge : PCR *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae* sur 1er jet d'urine
- Bilan d'IST en fonction des facteurs de risque

Epididymite aiguë et orchite aiguë, imagerie

- Non systématique
- Echographie scrotale recommandée si :
  - Doute diagnostic
  - Suspicion d'abcès
  - Persistance de la fièvre ou aggravation des signes locaux après 72h d'une antibiothérapie adaptée

Epididymite aiguë et orchite aiguë antibiothérapie initiale

- Traitement initié en milieu hospitalier :

  Céfotaxime IV 3 g/jour OU ceftriaxone IV 1 g/jour

- Traitement initié en ambulatoire :

  Ceftriaxone IV ou IM ou SC 1 g/jour

  OU ciprofloxacine PO 500 mgx2/jour OU lévofloxacine PO 500 mg/jour (en l'absence de prise de fluoroquinolones dans les 6 mois)

Le traitement d'une éventuelle IST n'est pas abordé dans cette recommandation

antibiothérapie, relais en fonction de l'antibiogramme (1)

- **Relais oral possible,** par ordre préférentiel
  - Sulfaméthoxazole-triméthoprime 800/160 mg 1 cpx2/jour
  - Ciprofloxacine 500 mgx2/jour OU lévofloxacine 500 mg/jour OU ofloxacine 200 mgx2/jour
- Si résistance ou contre-indication à l'association sulfaméthoxazole-triméthoprime et aux fluoroquinolones, après retour à l'apyrexie et par ordre préférentiel :
  - Amoxicilline 1 gx3/jour
  - Amoxicilline-acide clavulanique 1 gx3/jour
- **Pas de relais oral possible :** céfotaxime IV 3 g/jour OU ceftriaxone IV, IM ou SC 1 g/jour

Epididymite aiguë et orchite aiguë : antibiothérapie, relais en fonction de l'antibiogramme (2)

Enterobacterales résistantes aux C3G

- Par hyperproduction de céphalosporinase : céfépime IV 4 g/jour OU témocilline IV 6 g/jour
- Par production de BLSE :
  - 1er choix, par ordre alphabétique : céfoxitine IV 6 g/jour (seulement si *E. coli* ou *Proteus*) OU pipéracilline-tazobactam IV 12 g/jour OU témocilline IV 6 g/jour
  - A défaut, par ordre alphabétique : ertapénème IV 1 g/jour OU imipénème IV 3 g/jour OU méropénème IV 3 g/jour
- Relais oral, par ordre de préférence : Sulfaméthoxazole-triméthoprime 800/160 mg 1 cpx2/jour OU ciprofloxacine 500 mgx2/jour OU lévofloxacine 500 mg/jour OU ofloxacine 200 mgx2/jour

Epididymite aiguë et orchite aiguë durée de l’antibiothérapie

10 jours

Bilan systématique dès le 1er épisode d'infection urinaire (1)

- Interrogatoire orienté à la recherche d'une hématurie macroscopique ou de symptômes du bas appareil urinaire (SBAU), existant avant l'infection ou apparus depuis
- Calcul du score IPSS (International Prostate Symptom Score) (https://www.urofrance.org/fileadmin/medias/scores/score-IPSS.pdf)
- Réalisation d'un calendrier mictionnel si SBAU
- Toucher rectal à distance de l'épisode infectieux pour estimer le volume et la consistance de la prostate

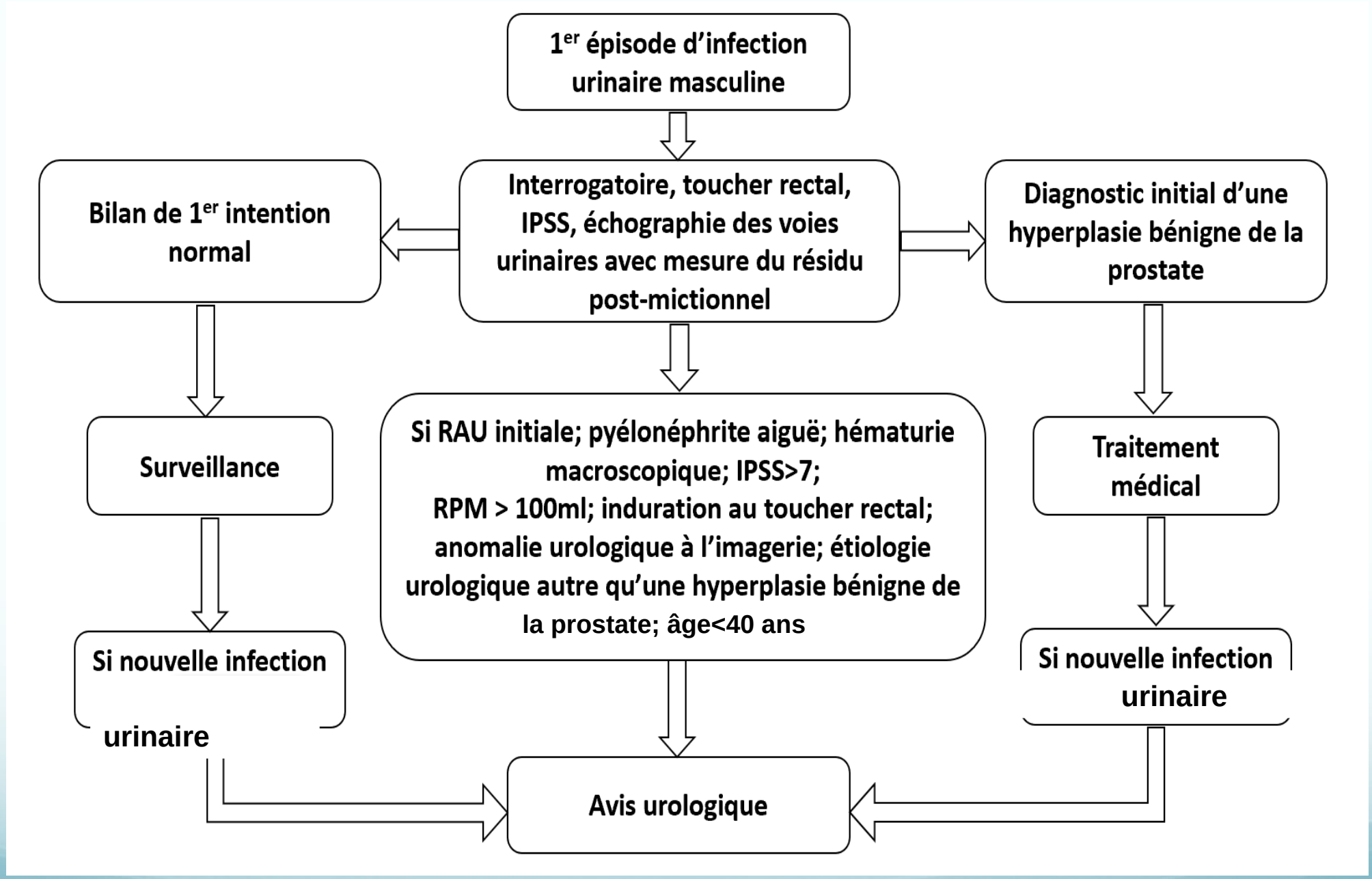
Bilan systématique dès le 1er épisode d'infection urinaire (2)

- Echographie des voies urinaires avec mesure du résidu post-mictionnel (RPM)
- Dosage du PSA : non systématique
  - Si dosage nécessaire : à réaliser au moins 3 mois après l'infection en tenant compte des indications retenues par les recommandations en vigueur de l'Association Française d'Urologie

Consultation en urologie

Recommandée si :

- Pyélonéphrite aiguë
- Rétention aiguë d'urine au diagnostic d'infection
- Hématurie macroscopique
- Score IPSS > 7
- Induration au toucher rectal
- RPM > 100 ml et/ou anomalie(s) urologique(s) sur le bilan d'imagerie



RAU: rétention aiguë d'urine; RPM: résidu post mictionnel, IPSS: International Prostate Symptom Score

Groupe de travail

F. Bruyère, W. Boutfol, Y. Caspar, V. Cattoir, A. Dinh, M. Etienne, E. Forestier, A. Hamon, V. Jullien, M. Lafaurie, A. Lefort, P. Lesprit, F. Lemaitre, H. Milacic, V. Orcel, A. Putot, C. Roubaud, B. Soudais, M. Vallée